

長寿 = 健康ではない

-- データで考える在宅医療の意義 --

研修医・専攻医向け | 15 分 | 2026-03-29

BMC Medicine 2026 -- Murata, Modig et al.

問い：なぜ日本人は長生きなのか？

あなたの答えを一つ、頭の中に思い浮かべてください

食事？ 遺伝？ 医療制度？ 運動習慣？

今日のデータは、その常識を覆すかもしれません

この勉強会のゴール

この 15 分の後、あなたは：

1. 日瑞比較研究の主要データを説明できる（理解）
2. 「長寿＝健康な国民」という仮説を批判的に吟味できる（分析）
3. 在宅医療の意義を国際比較データで語る準備ができる（創造）

前提知識：健康寿命と平均寿命

平均寿命：0 歳時点の平均余命

健康寿命：日常生活に制限なく生活できる期間

日本 (2022 年): 男性 81.05 歳 (健康寿命 72.57 歳)

女性 87.09 歳 (健康寿命 75.45 歳)

ギャップ = 不健康な期間：男性 約 8.5 年、女性 約 11.6 年

この「ギャップ」の期間に何が起きているかが、今日の論文の焦点です

研究の概要

Understanding Japan's mortality advantage (BMC Medicine, 2026.3.23)

研究チーム：カロリンスカ研究所 Karin Modig ら（九州大学・神戸大学と共同）

筆頭著者：Shunsuke Murata

デザイン：後ろ向きコホート（全人口レジストリデータ）

対象：75 歳以上 -- 日本 9 自治体 (33 万人超) vs スウェーデン (85 万人超)

分析手法：75 歳時の残余余命を「介護なし期間」と「介護受給期間」に分解

核心データ

指標	日本女性	スウェーデン女性	日本男性	スウェーデン男性
健康寿命（介護なし）	10.4 年	9.9 年	9.8 年	9.6 年
介護受給期間	5.1 年	3.8 年	2.2 年	2.1 年
75 歳時残余余命	15.5 年	13.7 年	12.0 年	11.7 年

健康寿命はほぼ同等。差が生まれているのは「介護を受けている期間」

核心的発見

日本の平均寿命の優位性は「介護受給者の低死亡率」に起因する

介護を受けずに暮らせる年数（健康寿命）は日瑞でほぼ差がない

日本女性の優位（+1.8 年）の大部分は介護受給期間の長さ（5.1 年 vs 3.8 年）

-> 介護受給者の死亡率が日本で有意に低い

Karin Modig: "Perhaps Japan's long life expectancy is not primarily due to the population being healthier"

批判的吟味

Strengths

全人口レジストリデータ（選択バイアス小）
75 歳以上に限定し比較可能性を確保
査読済み（BMC Medicine, IF 7.0+）

Limitations

「介護認定」の定義が日瑞で異なる
日本は 9 自治体のみ（全国代表性の限界）
死亡率の「なぜ」は未解明
交絡因子の調整が不十分な可能性

なぜ日本の介護受給者は死亡率が低いのか？

1. 在宅医療の充実：訪問診療・訪問看護の体制（日本のユニークさ）
2. 家族介護の文化：家族介護 + 公的サービスのハイブリッドモデル
3. 終末期医療の積極性：スウェーデンより積極的医療介入の傾向
4. 介護保険制度：2000 年導入、65 歳以上の 18.9% が要介護認定（676.6 万人）

対比：スウェーデンは COVID-19 初期に高齢者施設での死亡が突出（死亡者の 90% が 70 歳以上）

ペアディスカッション (4 分)

問い 1 (2 分)

あなたが担当している在宅患者さんを 1 人思い浮かべてください。
その方のケアのどの部分が「死亡率を下げる」ことに貢献していると思いますか？

問い 2 (2 分)

この研究の知見は、在宅医療の価値を患者・家族にどう説明するときに使えますか？

ディスカッション共有

期待される視点

訪問診療による早期介入（急変の早期発見）
多職種連携のシステム効果
家族を含めたケアチームの存在
「関係性のネットワーク」としてのケアシステム

倫理的問い

積極的医療介入が寿命延伸に寄与
-> 常に望ましいのか？
QOL と QOD のバランスは？

振り返り -- 3つの Key Takeaway

1. 日本の長寿は「健康な国民」ではなく
「ケアシステムの力」が主因かもしれない
2. 健康寿命は日瑞でほぼ同等
差は「介護受給者の死亡率」にある
3. あなたが関わる在宅ケアの一つ一つが
日本の長寿統計を支えている

持ち帰りの問い

明日の訪問診療で：「この患者さんのケアが、国際比較データの中の1データポイントである」と意識したとき、何が変わりますか？

さらに深めたい方へ

原著論文：BMC Medicine 2026 (左 QR)

カロリンスカ研究所プレスリリース (右 QR)



出典

1. Murata S, Modig K, et al. BMC Medicine. 2026. doi:10.1186/s12916-026-04786-z
2. OECD. Health at a Glance 2025: Japan. 2025.
3. 内閣府 . 令和 6 年版高齢社会白書 . 2024.
4. Tsutsui T. Int J Integr Care. 2014;14:e002.

教材ダウンロード (GitHub)

